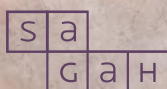


FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E SAÚDE

Ligia Maria Fonseca Affonso



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Centros de poder do hospital

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Apresentar a estrutura administrativa e médica do hospital.
- Comparar a influência das áreas diretivas com as áreas assistenciais.
- Demonstrar como o atendimento ao cliente desenvolve a humanização.

Introdução

A definição da estrutura administrativa e médica de um hospital não é algo simples e precisa ser muito bem pensada e planejada, considerando não só aspectos internos, como também os fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e demográficos que impactam diretamente na estrutura e no funcionamento da organização.

É importante ressaltar que essa estrutura deve estar também alinhada às estratégias da organização e aos perfis dos profissionais, bem como às necessidades e características da região onde a organização está inserida.

Neste capítulo, você vai conhecer a estrutura administrativa e médica de um hospital; a influência das áreas diretivas e das áreas assistenciais; e como o atendimento ao paciente desenvolve a humanização.

Estrutura administrativa e médica

Além da estrutura física, um hospital é formado por um conjunto de pessoas que interagem entre si com a finalidade de alcançar os objetivos e as metas estabelecidos. Ou seja, em um hospital, ou em qualquer outra organização, as pessoas precisam se relacionar interna e externamente para que possam atingir objetivos em comum. A administração hospitalar é uma tarefa complexa, especialmente por envolver a integração de diferentes recursos e processos com características distintas, comuns a qualquer empresa. Com essa diver-

cidade de atividades, funções, processos e profissionais, é necessário criar uma estrutura que defina como eles se combinam e se organizam para que o trabalho seja realizado. Isso quer dizer, que é necessário estruturar a forma como as pessoas se relacionam em atividades específicas e/ou em unidades de produção; sua autoridade; dependência; subordinação; etc.

Dessa forma, estruturar o funcionamento de um hospital é algo que deve ser muito bem pensado e desenhado, com cargos e funções claramente definidos e formalizados, de modo que a combinação de pessoas e equipes de trabalho seja realizada de forma sistemática, possibilitando alcançar os objetivos da organização. Assim, são aspectos fundamentais nesse processo: o conjunto de pessoas e o conjunto de funções administrativas que determinam como as atividades devem ser realizadas. A partir daí é possível constituir as funções de cada uma das unidades que produzem os serviços hospitalares e como elas podem interagir umas com as outras (MALAGÓN-LONDOÑO; PONTÓN LAVERDE; REYNALES LONDOÑO, 2019).



Saiba mais

A estrutura organizacional pode ser definida como um conjunto institucionalizado de relacionamentos que organizam o trabalho entre membros de uma organização cuja definição é de responsabilidade da alta direção (BRASIL, 2013; MALAGÓN-LONDOÑO; PONTÓN LAVERDE; REYNALES LONDOÑO, 2019).

Na organização estrutural e funcional de um hospital, alguns aspectos devem ser considerados:

- **missão:** que é a razão de ser do hospital e deve ser de conhecimento de todos na organização;
- **visão:** que é aonde o hospital deseja estar em longo prazo;
- **objetivos e metas:** que referem-se aos resultados que o hospital deseja alcançar;
- **características demográficas:** referem-se às taxas de natalidade, fertilidade; morbidade e mortalidade da população; idade, sexo, entre outros;
- **condições de saúde** da população atendida quanto à morbidade, mortalidade e incapacidade.

Conhecer esses aspectos é fundamental para identificar o perfil da população e a tendência de demanda de assistência, o que permite o planejamento das ações e serviços de que a mesma necessita. Ou seja, é essa previsão de demanda que permite determinar que tipos de serviços serão ofertados pelo hospital, em que nível de atendimento médico e em que grau de complexidade, que, por sua vez, determinam que tipo de recursos serão necessários para fazer frente aos serviços (BRASIL, 2007; MALAGÓN-LONDOÑO; PONTÓN LAVERDE; REYNALES LONDOÑO, 2019).



Saiba mais

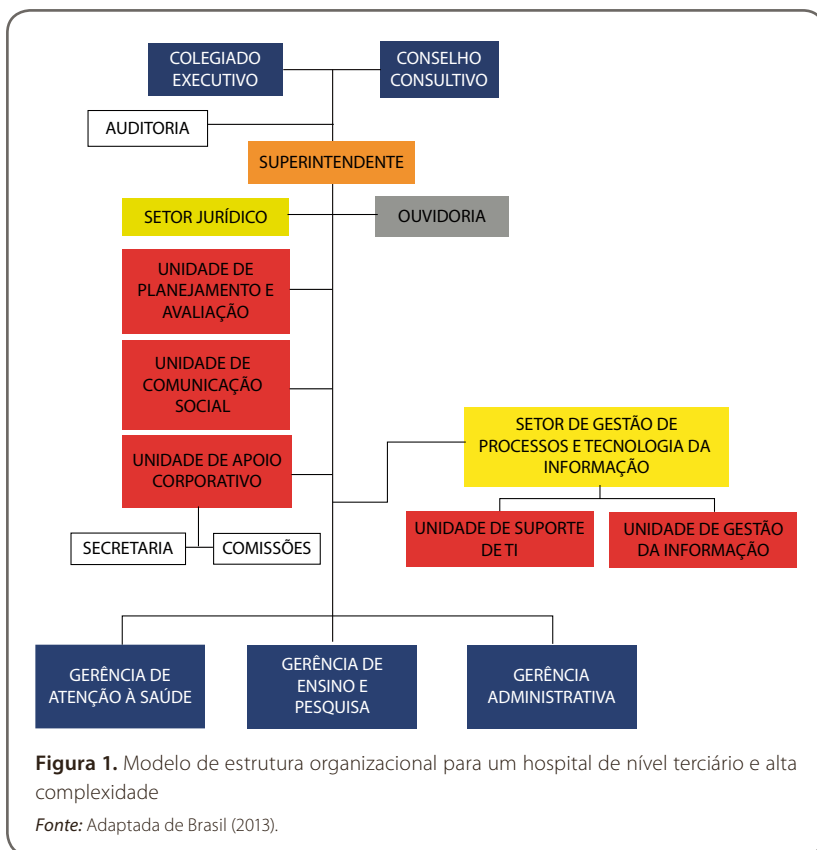
Os níveis de atendimento podem ser primários (atendimentos básicos que demandam tecnologia de baixa intensidade, com baixo grau de complexidade), secundários (atendimentos especializados que requerem profissionais especializados e tecnologias mais sofisticadas para exames de diagnóstico e tratamento, com médio grau de complexidade) e terciários (atendimentos em grandes hospitais que requerem alta tecnologia e altos custos; possuem alta complexidade) (BRASIL, 2007).

Após determinar os serviços que serão ofertados pelo hospital, é hora de distribuir responsabilidades e autoridade para tornar reais as metas de cada objetivo traçado. É assim que as divisões vão sendo construídas de modo a concretizar a missão da organização. Cabe destacar que a estrutura organizacional dos hospitais é distinta, dependendo do porte de cada um deles (MALAGÓN-LONDOÑO; PONTÓN LAVERDE; REYNALES LONDOÑO, 2019):

- Pequeno porte: menos de 200 leitos.
- Médio porte: entre 200 e 399 leitos.
- Grande porte: com 400 leitos ou mais.

Vamos ver uma estrutura organizacional em um hospital de nível terciário e de alta complexidade. É importante ter em mente que a organização estrutural e funcional deve considerar exclusivamente os serviços de saúde que irá oferecer. Como esse nível de atenção requer alta tecnologia para tratar as doenças que não puderam ser atendidas nos níveis inferiores de atenção, ele necessita, além de profundo conhecimento científico, de maior quantidade

de serviços clínicos e cirúrgicos do que os hospitais de menor complexidade. Veja na Figura 1 um exemplo de uma estrutura organizacional básica de um hospital de nível terciário.



Nesse exemplo você pode observar que no topo da estrutura estão o colegiado executivo e o conselho consultivo, seguidos da auditoria. O colegiado executivo é constituído pelo superintendente e por gerentes e é responsável pela direção e administração de todas as atividades da unidade. O conselho consultivo possui por finalidade orientar a atuação do colegiado executivo em relação ao planejamento estratégico e às ações do hospital. A área de auditoria, por sua vez, tem por objetivo avaliar e assessorar os gestores da

unidade, acompanhando a execução dos programas, o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão, entre outros (BRASIL, 2013).

Nesse modelo, é possível ver ainda o setor jurídico, cujo objetivo é prestar assessoria jurídica ao superintendente e gerentes do hospital em assuntos jurídicos específicos relacionados ao campo de atuação de cada um; a ouvidoria que, dentre outras atividades, é responsável por receber, analisar e registrar reclamações, sugestões, elogios, solicitações ou denúncias, dando o encaminhamento necessário a eles; e o setor de gestão de processos e tecnologia da informação, que tem por função dar apoio a todas as ações referentes à implementação e manutenção das tecnologias de informação do hospital. É possível ver ainda, nesse exemplo, unidades de planejamento e avaliação; comunicação social; de apoio corporativo; secretaria; setor de comissões e, finalmente, as áreas gerenciais de saúde, administrativa e de ensino e pesquisa (BRASIL, 2013).

Em relação à função educativa e de pesquisa de um hospital, é importante destacar que, aqui no Brasil, ainda é baixo o número de hospitais com graduação, pós-graduação e educação continuada. Normalmente, esses são hospitais universitários e de ensino, vinculados a faculdades. No exemplo de estrutura organizacional utilizado, teríamos ainda a gerência de ensino e pesquisa, formada pelo setor de gestão da pesquisa e inovação tecnológica, e o setor de gestão de ensino, responsável pelo gerenciamento de atividades dos cursos de graduação, pós-graduação e educação continuada.

Cabe destacar que, na definição da estrutura funcional de um hospital, é preciso considerar a missão, as metas e os objetivos traçados para a organização como um todo e a missão, as metas e os objetivos de cada uma das subdireções, divisões, departamentos, serviços e unidades (MALAGÓN-LONDOÑO; PONTÓN LAVERDE; REYNALES LONDOÑO, 2019).



Saiba mais

Além de ser uma organização médica e social, cuja principal finalidade é oferecer assistência médica integral, curativa e preventiva à população, um hospital caracteriza-se por ser uma estrutura formal com objetivos e ações bem definidas, que o levarão a obter os resultados pretendidos (MALAGÓN-LONDOÑO; PONTÓN LAVERDE; REYNALES LONDOÑO, 2019).

Áreas diretivas e assistenciais

No exemplo de estrutura organizacional de um hospital de grande porte visto na primeira parte deste material, foi possível observar duas áreas fundamentais para o funcionamento de um hospital: a área administrativa e a área de assistência à saúde. Veja algumas de suas responsabilidades:

Na estrutura administrativa de um hospital de alta complexidade estão as áreas (BRASIL, 2013):

- **Administrativo-Financeira:** setores de contabilidade; orçamento e finanças (tesouraria, contas a pagar, etc.) e administração (compras, contrato, patrimônio)
- **Logística e infraestrutura hospitalar:** setores de suprimentos (almo-xarifado); infraestrutura hospitalar; hotelaria; limpeza, alimentação, segurança, entre outros
- **Gestão de pessoas:** setores de administração de pessoal (seleção, contratação, plano de carreira, desenvolvimento profissional, etc); saúde ocupacional e segurança do trabalho.

Alguns hospitais possuem ainda um setor de engenharia e manutenção: com atividades como alocação, manutenção e reparos em equipamentos, transportes, serviços de hidráulica e elétrica, entre outros.

De modo geral, cabe à gerência administrativa:

- gerenciar e implementar as políticas de gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, bem como as políticas de gestão de logística, de infraestrutura física e tecnológica e de gestão de pessoas;
- elaborar o orçamento anual e a prestação de contas do hospital;
- gerenciar: custos, buscando maior eficiência; o patrimônio, garantindo o inventário e manutenção dos bens; aquisições de bens, serviços e insumos necessários; execução de serviços operacionais; a capacitação e o desenvolvimento dos profissionais;
- cumprir a legislação vigente;
- outras atividades relacionadas às áreas administrativas.

Em relação à gerência de assistência à saúde, do mesmo exemplo acima, temos a seguinte divisão (BRASIL, 2013).

Divisão de gestão do cuidado: gerenciamento do cuidado em saúde; planejamento, organização, gerenciamento, monitoramento e avaliação das linhas de cuidado; definição de metas quantitativas e qualitativas da atenção à saúde e de indicadores de monitoramento e avaliação; gerenciamento dos leitos hospitalares e de mecanismos de alta hospitalar; coordenação das atividades da equipe multiprofissional de saúde ligada à Divisão; acompanhamento do abastecimento regular de instrumentais, medicamentos e insumos necessários ao funcionamento das Unidades Assistenciais ligadas à Divisão.

Divisão médica: coordenação da equipe médica; supervisão da execução das atividades de assistência médica; elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas das unidades assistenciais, setores e divisões da atenção à saúde; planejamento, coordenação e execução de programas, estudos, pesquisas e demais atividades de saúde; elaboração de relatórios sobre a assistência médica do hospital; entre outros.

Divisão de enfermagem: coordenação da equipe de enfermagem; garantia da prestação da assistência de enfermagem em todas as áreas de atendimento, em quantidade e qualidade; determinação de diretrizes da assistência de enfermagem de acordo com as diretrizes da gestão do cuidado; avaliação de desempenho técnico das equipes de enfermagem e de seu comportamento; garantia do atendimento humanizado; conhecimento das necessidades dos usuários nas ações assistenciais; entre outros.



Saiba mais

As divisões de gestão do cuidado e médica incorporam as unidades especializadas, como cardiologia, saúde da mulher, oncologia, hematologia, cirurgia geral, clínica médica e outras. A divisão de enfermagem possui interação com todas as unidades de saúde do hospital (BRASIL, 2013).

Divisão de apoio diagnóstico e terapêutico: coordenação de ações de apoio diagnóstico e terapêutico do hospital; planejamento, monitoramento e avaliação das ações de apoio diagnóstico e terapêutico; coordenação das atividades da equipe multiprofissional de saúde ligada ao setor; definição de metas qualitativas e quantitativas do setor e de indicadores de monitoramento e avaliação;

elaboração e implementação de protocolos clínicos referentes às unidades assistenciais vinculadas ao setor; entre outros.



Saiba mais

A divisão de apoio diagnóstico e terapêutico incorpora algumas unidades, como cirurgia e recuperação pós-anestesia (RPA); materiais esterilizados; unidade de terapia intensiva e semi-intensiva; reabilitação, nutrição; laboratório de análises clínicas; diagnóstico por imagem, entre outros (BRASIL, 2013).

Setor de farmácia: responsável pelo abastecimento e dispensação de medicamentos. Realiza a dispensação de medicamentos e demais produtos para saúde; participa em comissões técnicas da instituição; requisita, armazena, controla e distribui insumos; fraciona medicamentos; manipula e produz medicamentos; verifica e repõe os estoques das áreas hospitalares; colabora na elaboração dos protocolos terapêuticos, manuais técnicos e formulários; entre outros.

Setor de vigilância em saúde: responsável por ações de vigilância em saúde e gestão e riscos assistenciais. Planejamento, implementação e coordenação de ações de vigilância epidemiológica e ambiental: controle de infecção hospitalar, análise de óbitos e revisão de prontuários; prevenção e controle de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; implementação de diretrizes de prevenção e controle de infecção hospitalar; acompanhamento e avaliação de ações de prevenção e controle de infecção hospitalar; identificação e avaliação do perfil de morbimortalidade hospitalar; apoio às atividades de planejamento, monitoramento e avaliação da gerência de atenção à saúde; entre outros.

Setor de regulação e avaliação em saúde: regulação, monitoramento e avaliação da assistência; regulação do fluxo assistencial intra-hospitalar, ambulatorial e de internação; avaliação da produção ambulatorial e hospitalar; revisão das contas médicas; monitoramento e avaliação de indicadores de desempenho da área assistencial, entre outros.

As áreas administrativas e de atenção ao cuidado devem garantir o exercício ético dos profissionais que atuam em suas respectivas áreas; garantir o cumprimento do regimento interno do hospital e das divisões, setores e unidades assistenciais; zelar pelo bom clima no ambiente de trabalho e estimular a

boa relação entre todos os profissionais do hospital e entre setores, divisões e unidades; promover o atendimento humanizado a pacientes e a todos os profissionais do hospital.

Cabe destacar que não existe uma estrutura organizacional padrão para hospitais. Essa estrutura é definida de acordo com vários aspectos como o perfil da demanda; aspectos demográficos e de saúde, missão, visão e valores da organização, recursos demandados, entre outros. Importante citar que a definição da estrutura organizacional deve estar alinhada, além dos aspectos mencionados acima, às estratégias da organização. São esses e outros aspectos que diferenciam a estrutura organizacional entre os hospitais.



Fique atento

Na definição da estrutura funcional de um hospital, é preciso considerar a missão, as metas e os objetivos traçados para a organização como um todo e a missão, metas e objetivos de cada uma das subdireções, divisões, departamentos, serviços e unidades (MALAGÓN-LONDOÑO; PONTÓN LAVERDE; REYNALES LONDOÑO, 2019).

Não há como afirmar que uma determinada área em um hospital seja mais importante que outra, pois todas as áreas são partes de um todo e todas trabalham para alcançar o mesmo objetivo. A área diretiva de um hospital tem como responsabilidade dirigir e administrar todas as atividades da unidade. A área médica tem por responsabilidade gerenciar todos os profissionais médicos e todas as unidades ligadas ao cuidado em saúde. Podemos pensar que a área médica exerça uma influência maior que a área diretiva, uma vez que ela gerencia os profissionais que lidam diretamente com o paciente. No entanto, a área diretiva também exerce influência em relação aos pacientes. Dessa forma, podemos dizer que ambas se influenciam mutuamente. Ou seja, as decisões da área administrativa interferem diretamente na atenção à saúde, da mesma forma que decisões, comportamentos e atitudes da área médica exercem impactos na área administrativa. Uma redução no quadro de funcionários, decidida pela área administrativa, por exemplo, pode impactar na qualidade dos serviços de saúde prestados, uma vez que tal redução implica em demissões; distribuição de responsabilidade daqueles profissionais que se desligaram entre os demais profissionais do hospital; aumento da carga horária e da carga de atividades executada, que interfere na produtividade

dos profissionais e, consequentemente, impacta na qualidade dos serviços que são prestados aos pacientes. Por outro lado, se a administração médica ou de cuidado em saúde, por exemplo, envia um relatório à direção informando a necessidade de ampliação dos leitos hospitalares para o atendimento do aumento da demanda, está exercendo influência sobre a direção administrativa, uma vez que a mesma deverá providenciar os recursos necessários para tal necessidade, o que implica em aumento de gastos e custos hospitalares. De qualquer forma, as duas áreas exercem grande influência sobre o cuidado em saúde, sobre as práticas de gestão e sobre a prestação de serviços de qualidade.

Atendimento humanizado

Você sabe como surgiu esse movimento pela humanização na saúde? A necessidade de humanizar os serviços de saúde surgiu após uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (MS), na década de 1990, que identificou que o respeito no atendimento era a necessidade mais valorizada entre os usuários do sistema de saúde. Essa e outras necessidades e problemas mostraram que havia urgência na reestruturação da política de saúde, de um modo geral. Assim, no ano 2000 nasceu o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), com o objetivo de inserir a prática humanizada em hospitais. A iniciativa deu tão certo que, em 2003, o MS lançou o Humaniza SUS — Política Nacional de Humanização (PNH). Desde seu lançamento, a humanização vem deixando de ser um simples conceito e se transformando em uma cultura em diversas organizações (REIS, 2013).

Desde essa época a humanização vem sendo bastante disseminada, não só na saúde como em outras áreas da administração pública e privada. O avanço da tecnologia de modo geral tem provocado diversas mudanças no ambiente das organizações e nas relações entre as pessoas. Na área da saúde isso é acentuado pelo avanço da medicina, do conhecimento, das técnicas, exames e equipamentos de diagnóstico de última geração, que acabam separando a doença do ser humano que a possui. Ou seja, toda a tecnologia que envolve o atendimento em saúde tem tornado o relacionamento entre as pessoas cada vez mais frio, contribuindo para desumanizar também os profissionais de saúde, que reproduzem isso em sua prática.

A desumanização nesse contexto contribui para aumentar o sentimento de impotência e abandono do paciente, desacreditando a possibilidade de recuperação e cura. É importante considerar que a pessoa quando se encontra

em quadro de enfermidade carrega consigo um conjunto de sentimentos, como medo, ansiedade, angústia e insegurança, entre outros. Ela enxerga na figura do médico a esperança de cura. No entanto, tem sido grande a reclamação de que os médicos atualmente não olham nos olhos do paciente e nem os tocam, o que confirma o atendimento da doença dissociada do ser humano.



Saiba mais

A desumanização da gestão e do cuidado em saúde pode ser representada pelas filas, pelo afastamento dos pacientes de seus familiares durante o período de internação, por práticas de gestão autoritárias, condições de trabalho inadequadas e por profissionais desvalorizados e insatisfeitos, entre outros (ARANGO, 2011).

Nesse momento de fragilidade e de vulnerabilidade, é fundamental que o médico e os demais profissionais de saúde dispensem aos pacientes uma atenção diferenciada, transmitindo a eles otimismo, segurança, confiança e esperança. Dessa forma, cabe aos profissionais de saúde prestar um atendimento mais humano aos pacientes, tendo por eles respeito; compreensão de sua dor; e capacidade de escutar e servir (OSEGUERA, 2006; ARANGO, 2011; MALAGÓN-LONDOÑO; PONTÓN LAVERDE; REYNALES LONDOÑO, 2019).

Na assistência à saúde, médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde devem ter como aspectos de sua conduta a empatia, a autenticidade, a compaixão, a fidelidade, a integridade, o respeito, a espiritualidade e a virtude, que podem ser reunidas da seguinte forma (OSEGUERA, 2006; BRASIL, 2018):

- respeito aos pontos de vista do paciente, considerando sua opinião nas decisões;
- zelo pelo bem-estar emocional do paciente, lembrando de que ele é único;
- oferecimento de tratamento adequado ao paciente, considerando os contextos familiar, social e físico;
- saber comunicar e escutar;
- transmissão de confiança ao paciente por meio da atenção e da confidencialidade;

- fornecimento das informações necessárias aos pacientes e seus familiares, respeitando sua privacidade e autonomia e preservando seus direitos;
- consideração dos usuários como parceiros na prevenção e promoção da saúde.

Essas são algumas ações por meio das quais a humanização se desenvolve no atendimento aos pacientes.

Humanizar não diz respeito somente ao relacionamento dos profissionais de saúde com os pacientes, mas também a prestar atendimento de qualidade, alinhando os avanços tecnológicos ao acolhimento; melhorando o ambiente de cuidado e as condições de trabalho dos profissionais. Dessa forma, o objetivo da PNH é qualificar as práticas de gestão e de atenção em saúde. Ou seja, podemos entender a humanização como uma estratégia de intervenção nos processos de produção do cuidado e nas práticas de gestão com a participação de todos os envolvidos: profissionais da saúde e profissionais das demais áreas do hospital, pacientes e gestores. Isso quer dizer que a humanização deve abranger todos os setores do hospital. A partir dessa perspectiva, humanizar a assistência hospitalar abrange o acolhimento e atendimento dos usuários, o trabalho dos profissionais e as práticas de gestão e gerência (BRASIL, 2004).



Fique atento

Para trabalhar a humanização é necessário elaborar planos de ação, priorizando os problemas mais urgentes que devem ser solucionados. Cada hospital elabora seu plano de ações de acordo com suas particularidades e com o meio onde está inserido (BRASIL, 2009).

Você sabe o que é o acolhimento em hospitais? O acolhimento em um hospital significa escutar as necessidades de saúde do paciente assim que ele procura pelos serviços de saúde e prestar a ele os cuidados de que necessita, de forma ética e adequada, com resolutividade e responsabilidade. Ou seja, é oferecer atendimento eficiente, com escuta atenta e respostas adequadas às dúvidas dos pacientes.

Você concorda que escutar o paciente permite a indicação de tratamento e tecnologias adequadas a seu problema de saúde, ampliando as chances de sucesso no tratamento? Escutar o paciente permite ainda avaliar sua situação em relação à vulnerabilidade, gravidade e risco, permitindo a elaboração de um projeto de cuidado individual e adequado ao paciente. Nesse sentido, o acolhimento representa uma ferramenta de construção de vínculo, ou seja, de aproximação entre pacientes e profissionais de saúde.



Fique atento

O acolhimento não é o mesmo que triagem. A triagem termina após o paciente ser atendido na recepção quando dá entrada no hospital. O acolhimento é uma prática de inserção do paciente naquele ambiente e deve ser contínuo durante toda a sua permanência na instituição (BRASIL, 2009).

Cabe destacar que, quando acolhido, o paciente se sente cuidado e, se há o vínculo, há confiança no profissional. Isso faz com que o paciente acabe aderindo e colaborando com o tratamento, seguindo as orientações médicas, aumentando, assim, suas chances de cura e restabelecimento.

Como já foi dito anteriormente, as práticas de humanização também devem ser voltadas a todos os profissionais que trabalham em um hospital, sejam eles da assistência à saúde ou das áreas administrativas. Esses profissionais possuem uma particularidade: além do alto esforço físico e intelectual exigido para o exercício de suas atividades, esses profissionais ainda sofrem o desgaste emocional decorrente do contato direto com os pacientes, que fazem surgir muitas vezes emoções e conflitos, levando ao sofrimento.

Cabe lembrar que, em um hospital público, esses aspectos são agravados muitas vezes por condições de trabalho insalubres, baixos salários e falta de recursos para a realização de atividades, etc. Esses aspectos são fatores que podem provocar insatisfação nesses profissionais, impactando diretamente na qualidade dos serviços de saúde prestados (RIOS, 2008).

Dessa forma, humanizar o trabalho dos profissionais refere-se a (BRASIL, 2008; 2009; 2013):

- promover espaços acolhedores e que propiciem mudanças no processo de trabalho, onde os profissionais possam se encontrar com os colegas e tenham sua privacidade respeitada;
- estimular o trabalho em equipe, possibilitando a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes e serviços, profissionais e equipes, e entre os profissionais em geral;
- reconhecimento e valorização dos profissionais, considerando suas experiências e permitindo sua participação nas decisões, respeitando sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. A participação nas tomadas de decisão melhora as relações entre profissionais e gestão e, conseqüentemente, dos profissionais com os pacientes. Além disso, dá às equipes maior autonomia e possibilidade de desenvolvimento;
- desenvolvimento do profissional, provendo programas de aprimoramento da execução das ações e serviços de saúde, treinamento, capacitação e educação permanente. Destacam-se também o estímulo à leitura de materiais atualizados das áreas pertinentes, por meio de biblioteca física ou virtual, e a participação desses em eventos científicos;
- humanizar todas as práticas de gestão de pessoas: estabilidade no emprego; política de salários e benefícios; anos de carreira, entre outros.

Todas essas ações são capazes de estimular a motivação, o comprometimento e o aumento da satisfação dos trabalhadores. Não se pode esquecer que o sucesso de uma organização depende de pessoas motivadas, criativas e com conhecimentos e habilidades que as permitam executar suas atividades com excelência. Conseqüentemente, esse sucesso depende de oportunidades de aprendizado e de um ambiente favorável ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades.

Em relação à humanização das práticas de gestão, o modelo proposto pela PNH tem seu foco no trabalho em equipe; na construção coletiva; e em espaços coletivos que permitam que o poder seja realmente compartilhado. Dessa forma é necessária a criação de espaços de diálogo entre administradores e profissionais da saúde, privilegiando práticas de gestão participativa e permitindo a escuta da voz dos profissionais. A voz de pacientes e seus familiares também é ouvida e as propostas de mudanças aos modos de cuidar e à gestão são construídas de forma coletiva. Você consegue mensurar a importância da participação das pessoas em todos os aspectos do trabalho? Essa participação

é um elemento essencial para criar sinergia dentro das equipes, e a autonomia proporcionada por ela facilita a formação de equipes de alto desempenho no alcance das metas estabelecidas.

É importante lembrar que a humanização na gestão consiste em desenvolver um modelo de gestão sistêmico, integrado e que possibilite que as ações necessárias para o atendimento humanizado aconteçam naturalmente e não por obrigação. A complexidade cada vez maior dos serviços hospitalares exige práticas de gestão humanizadas que compensem toda a tecnologia que intermedia as relações de trabalho e as relações entre as pessoas, não esquecendo que as pessoas são as responsáveis por fazer o hospital funcionar e cumprir sua missão (RIOS, 2008; MALAGÓN-LONDOÑO; PONTÓN LAVERDE; REYNALES LONDOÑO, 2019).

Assim, a humanização hospitalar deve se entender como um processo que permite a concretização de um ambiente coletivo que favoreça maior pessoalidade, satisfação, cordialidade e solidariedade entre os profissionais e entre estes e os pacientes. Nesse sentido, pode-se dizer que humanizar é redefinir práticas, processos e ambiente de trabalho, evitando que aspectos como o estresse, o desconforto e a insatisfação levam a práticas mecanizadas de trabalho.

Dessa forma, a elaboração da estrutura funcional de um hospital deve levar em consideração a cultura de humanização, estendida não só a todos os seus profissionais, como também a todas as divisões, setores e unidades.



Link

Para ler sobre a humanização no setor público acesse o link a seguir.

<https://goo.gl/nt4zt>



Referências

ARANGO P. ¿Qué es la humanización en salud? In: CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA, 1., 2011. *Memorias...* [S. l.]: Fundación Colombiana de Ética y Bioética, 2011. p. 82.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009a. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível

em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_classificacao_risco_servico_urgencia.pdf. Acesso em: 20 mar. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. *HumanizaSUS*: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasisus_2004.pdf. Acesso em: 20 mar. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. *HumanizaSUS*: gestão participativa e cogestão. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009b. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestao_participativa_cogestao.pdf. Acesso em: 20 mar. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Portaria GM/MS nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013*. Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Brasília, DF, 2013a. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3390_30_12_2013.html. Acesso em: 20 mar. 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. *Estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEERH*: diretrizes técnicas. Brasília, DF, 2013b. Disponível em: http://www2.ebserh.gov.br/documents/222346/866032/EBSEERH_Estrutura+Organizacional+dos+HUs+so+b+gest%C3%A3o+da+EBSEERH.pdf/f31541d2-a849-4ab9-a2b7-9de9e01d1acb. Acesso em: 20 mar. 2019.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. *Assistência de média e alta complexidade no SUS*. Brasília, DF: CONASS, 2007. (Coleção Progestores). Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colecao_progestores_livro9.pdf. Acesso em: 20 mar. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Trabalho e redes de saúde valorização dos trabalhadores da saúde*. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/trabalho_redes_saude_2ed_2008.pdf. Acesso em: 20 mar. 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretriz EBSEERH de humanização: assistência humanizada para melhoria da qualidade em saúde. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. (Série Diretrizes Ebserh sobre Humanização). Disponível em: <http://www2.ebserh.gov.br/documents/695105/2749071/Diretriz+Humaniza%C3%A7%C3%A3o.pdf/614821e2-79b1-44d4-bd17-f6c7752ed0fe>. Acesso em: 20 mar. 2019.

MALAGÓN-LONDOÑO, G.; PONTÓN LAVERDE, G.; REYNALES LONDOÑO, J. *Gestão hospitalar para uma administração eficaz*. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

OSEGUERA, J. El humanismo en la educación médica. *Revista Educación*, v. 30, n. 1, p. 51-63, 2006.

REIS, F. *Humanização na saúde*. Rio de Janeiro: Editora DOC, 2013.

RIOS, I. C. Humanização e ambiente de trabalho na visão de profissionais da saúde. *Saúde Sociedade*, v. 17, n. 4, p. 151-160, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v17n4/15.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2019.

Leituras recomendadas

BRASIL. Ministério da Saúde. *Carta dos direitos dos usuários da Saúde*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_direito_usuarios_2ed2007.pdf. Acesso em: 20 mar. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. *Acolhimento nas práticas de produção de saúde*. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_praticas_producao_saude.pdf. Acesso em: 20 mar. 2019.

D'AGUIAR, E. *Gestão hospitalar: o papel do médico gestor*. Rio de Janeiro: Editora DOC Content, 2006.

GONÇALVES, E. L. (Org.). *Gestão hospitalar: administrando o hospital moderno*. São Paulo: Saraiva, 2006.

VECINA NETO, G.; MALIK, A. M. *Gestão em saúde*. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS